

Oggi: cosa dovrete sapere?

1. **Distinguere i quadri cognitivi** DNC minore, DNC maggiore, demenza, delirium.
2. **Capire le traiettorie** Miglioramento, stabilità, peggioramento.
3. **Valutare i BPSD** NPI/NPI-Q, bisogni non soddisfatti, ABC, DICE.

Parte 1 — Disturbi neurocognitivi

Caso guida: Maria

Maria, 78 anni. Da circa un anno dimentica alcuni appuntamenti.

Usa molti promemoria.

La figlia riferisce qualche errore recente nelle bollette.

Che cosa dobbiamo capire?

Tre domande iniziali

1. C'è un **declino** rispetto a prima?
2. Quali **domini cognitivi** sono coinvolti?
3. L'autonomia è **compromessa**?

Declino rispetto a prima

Non basta “andare male” a un test

Conta il cambiamento rispetto al funzionamento abituale.

Domini cognitivi da osservare

Memoria ripetizioni, appuntamenti

Linguaggio parole, comprensione

Funzioni esecutive pianificazione, giudizio

Attenzione fluttuazioni, distraibilità

Prassie/gnosie uso di oggetti

Cognizione sociale disinibizione, empatia

Autonomia: il nodo centrale

Difficoltà cognitive simili

possono avere impatto funzionale diverso.

Maria: due scenari

Scenario A Vive sola, gestisce farmaci e spese. Usa agenda e promemoria.

Scenario B La figlia ha preso in carico farmaci e pagamenti per errori ripetuti.

Cosa cambia?

DNC minore e maggiore

Aspetto	DNC minore	DNC maggiore
Declino cognitivo	modesto	significativo
Autonomia	conservata, con più sforzo o strategie	compromessa
Termine vicino	MCI	demenza

Demenza: una sindrome

Non una singola malattia.

- declino cognitivo acquisito;
- impatto su autonomia e vita quotidiana;
- cause diverse;
- andamento non identico per tutti.

Delirium: da non perdere

Acuto · fluttuante · attenzione alterata

Un peggioramento improvviso non va attribuito automaticamente alla demenza.

Traiettorie possibili

Disturbo cognitivo $\neq$ destino unico

Miglioramento · stabilità · peggioramento

Cognizione e umore

Depressione → cognizione

attenzione, memoria, rallentamento

Cognizione → umore

frustrazione, perdita di ruolo, ritiro

Attività 1 · Quale quadro?

Per ogni situazione:

1. minore, maggiore, delirium o dati insufficienti?
2. quale traiettoria è possibile?
3. quali informazioni mancano?

Quattro situazioni

- A.** Dimentica appuntamenti, ma gestisce ancora farmaci e spese.
- B.** Da due anni peggiora; ora la figlia gestisce farmaci e pagamenti.
- C.** Tristezza, ritiro e difficoltà di concentrazione da alcuni mesi.
- D.** Difficoltà cognitive migliorate dopo correzione di fattori reversibili.

Debriefing: tre domande

1. Il deficit interferisce con l'autonomia?
2. L'andamento è acuto, progressivo o fluttuante?
3. Umore, farmaci o malattie acute possono contribuire?

Le principali forme

Stesso esito funzionale, ingressi diversi

Memoria · esecutivo · fluttuazioni · comportamento · linguaggio

Alzheimer: nuove informazioni

Primo segnale frequente

Difficoltà a fissare e recuperare nuove informazioni.

Alzheimer: cosa osserva l'educatore?

- ripetizioni;
- difficoltà nella routine;
- bisogno di promemoria;
- smarrimento;
- ansia quando aumenta la richiesta.

Demenza vascolare: esecutivo e ritmo

Non sempre il primo problema è la memoria

Rallentamento · pianificazione · iniziativa · cammino

Vascolare: cosa osserva l'educatore?

- difficoltà a organizzare la giornata;
- lentezza nelle transizioni;
- fatica a iniziare;
- cadute o insicurezza nel cammino;
- bisogno di struttura esterna.

Corpi di Lewy: fluttuazioni

Giornate diverse, prestazioni diverse

Fluttuazioni · allucinazioni visive · parkinsonismo · sonno REM

Lewy: cosa osserva l'educatore?

- alternanza di lucidità e confusione;
- visioni ricorrenti;
- rallentamento motorio;
- cadute;
- sonno agitato riferito dai caregiver.

Frontotemporale: comportamento o linguaggio

Il primo problema può essere sociale

Disinibizione · apatia · perdita di empatia · rituali · afasia

FTD: cosa osserva l'educatore?

- violazione di regole sociali;
- riduzione dell'iniziativa;
- comportamenti ripetitivi;
- cambiamento alimentare;
- difficoltà comunicative.

Nell'anziano: forme miste

Pattern utili, non scatole rigide

Neurodegenerazione · vascolare · fragilità · farmaci · ambiente

Percorso diagnostico

- anamnesi ed eteroanamnesi;
- cognizione e funzione;
- clinica, farmaci, comorbidità;
- esami mirati e imaging quando indicato;
- follow-up.

Che cosa documenta l'educatore

Funzione reale

- igiene, alimentazione, vestirsi;
- orientamento;
- routine;
- partecipazione.

Contesto e relazione

- quando accade;
- con chi;
- dove;
- che cosa aiuta o peggiora.

PAUSA

10 minuti

Parte 2 — BPSD / NPS

Caso guida BPSD

Ore 17:30. Una signora tenta ripetutamente di uscire dalla struttura.

Dice: «Devo andare a prendere i bambini».

Si irrita quando l'operatore prova a fermarla.

Ora il focus è il comportamento.

BPSD: che cosa sono

Alterazioni di:

percezione · pensiero · umore · comportamento · motricità · sonno

Manifestazioni diverse, cause diverse, interventi diversi.

Prima domanda di sicurezza

È un cambiamento improvviso?

Delirium · dolore · infezione · stipsi · ritenzione urinaria · farmaci · disidratazione · ipoacusia · ipovisione

Dal racconto alla raccolta standardizzata

«È agitata» non basta

Quale sintomo? Quanto grave? Quanto pesa sul caregiver?

NPI e NPI-Q

NPI	NPI-Q
intervista strutturata	questionario breve
frequenza × gravità	gravità
distress caregiver	distress caregiver

NPI-Q: che cosa raccoglie?

12 domini neuropsichiatrici

Gravità del sintomo nella persona

Distress del caregiver

Periodo: ultimo mese

Materiale NPI-Q

Per l'attività

- domini;
- gravità;
- stress caregiver;
- limiti dello strumento.

[Apri NPI-Q italiano](#) ■



Dimostrazione guidata

La caregiver dice:

| «È più nervosa. La sera vuole uscire. Se le dico che non può, si arrabbia.»

Quale dominio potremmo esplorare?

Esempio: non saltare al punteggio

Dominio possibile: agitazione/aggressività

Domande utili: che cosa fa? quanto dura? c'è rischio? quanto spesso? cosa succede dopo?

Poi: gravità e stress del caregiver

Attività 2 · NPI-Q guidato

Una figlia riferisce:

«Mia madre continua a chiedere quando arriva la nipote. È più nervosa del solito. La sera dice che le rubano le cose. Io faccio fatica.»

Compilate la scheda di ragionamento.

Scheda di ragionamento

Dominio possibile	Cosa chiedere?	Cosa non sappiamo ancora?
...	...	...
...	...	...

Debriefing NPI-Q

Misura e standardizza
ma
non spiega da solo

Abbiamo descritto. Ora dobbiamo capire.

Perché potrebbe accadere?

Stesso comportamento, spiegazioni diverse.

Bisogni non soddisfatti

Un comportamento può comunicare un bisogno:

sicurezza · dolore · movimento · relazione · ruolo · controllo · ambiente più adatto

Quattro famiglie di ipotesi

Cliniche dolore, delirium, farmaci, sonno

Personali biografia, emozioni, identità

Ambientali rumore, luce, spazi, sovraccarico

Relazionali comunicazione, richiesta, perdita di controllo

ABC: descrivere l'episodio

A — Antecedent	B — Behavior	C — Consequence
prima	comportamento	dopo
ora, luogo, richiesta, persone	cosa fa/dice	risposta, esito, rinforzi

Caso guida: dati aggiuntivi

- Succede quasi sempre tra 17:00 e 18:00.
- In passato andava a prendere i figli a scuola.
- Il cambio turno rende l'ambiente più rumoroso.
- Se cammina con un'operatrice si calma per qualche minuto.

Ora possiamo formulare ipotesi.

Esempio guidato: routine biografica

Ipotesi Il tardo pomeriggio richiama una routine significativa del passato.

Che cosa verificare? Storia di vita, orari, risposta ad attività familiari.

DICE: organizzare il percorso

Describe → descrivere

Investigate → cercare cause modificabili

Create → creare un piano personalizzato

Evaluate → valutare e correggere

Dall'ipotesi all'intervento

Ipotesi	Intervento coerente	Come valutarlo?
routine biografica	attività ponte significativa nel tardo pomeriggio	distress, coinvolgimento, sicurezza

Un esempio. Le altre possibilità le cercate voi.

Attività 3 · Completate il progetto

Il comportamento è già descritto. **Non ripetete l'esempio.**

1. Formulate **un'altra ipotesi**.
2. Indicate **un dato** per approfondirla.
3. Proponete **un intervento coerente**.
4. Definite **come valutarlo**.

Sintesi finale

Descrivere prima di interpretare.

Misurare senza ridurre la persona al punteggio.

Ipotizzare prima di intervenire.

Valutare e modificare.

Da ricordare per l'esame

- DNC minore vs maggiore: il ruolo dell'autonomia.
- Delirium: acuto, fluttuante, attenzione alterata.
- Traiettorie: miglioramento, stabilità, peggioramento.
- BPSD: descrivere e standardizzare.
- NPI-Q: domini, gravità, stress caregiver.
- DICE: descrivere, investigare, creare, valutare.

Fonti e materiali

- WHO. Dementia fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
- NICE NG97. Dementia: assessment, management and support. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng97>
- IPA. Complete Guide to BPSD. https://www.ipa-online.org/UserFiles/file/IPA_BPSPD_Specialists_Complete_Guide_Online_2015_Final.pdf
- Kales, Gitlin, Lyketsos. DICE approach. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4146407/>
- NPI-Q italiano. https://www.demenzemedicinagenerale.net/images/test/NPI-Q_12-11-2016_SITO.pdf
- Sito ufficiale NPI. <https://mail.npittest.net/npi/about-npi.html>